

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE SÉPTICO (En triaje)

Paciente con **SOSPECHA de INFECCIÓN**

- El paciente que presente **cualquiera** de los siguientes síntomas activaría el protocolo:
- Fiebre o hipotermia.
- Tiritonas/escalofríos.
- Semiología focal infecciosa, lesiones cutáneas (rash, petequias, livideces, cianosis...).
- En pacientes con mayor riesgo de infecciones graves: cualquier síntoma agudo o afectación considerable del estado general sin una clara atribución etiológica alternativa.
- Alteraciones en pruebas de laboratorio (si están disponibles).

Valorar
GRAVEDAD

Constantes vitales:
(FR, TA, Tª, FC y
PULSIOXIMETRÍA)

EVALUACIÓN DE LA GRAVEDAD MEDIANTE LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

- FR > 21
- Cualquier alteración del nivel de conciencia (Glasgow < 15)
- TA Sistólica < 100 mmHg
- Hipoxemia (Sat. O₂ < 95)

≤ 1 CRITERIOS

≥ 2 CRITERIOS

AVISAR AL MÉDICO RCP

Medico NO confirma sospecha

Medico confirma sospecha

ACCIONES PARA PACIENTE CON SOSPECHA DE INFECCIÓN GRAVE

EL PACIENTE PASA A CIRCUITO
POLIVALENTES y Clasificar en
DIRAYA con prioridad 2

Aviso al clínico para continuar
valoración

Confirmar actuación en
evolutivo reflejando la hora

EL PACIENTE PASA A
BOX de CRÍTICOS y se
clasifica en DIRAYA con
prioridad 1

Confirmar activación
del protocolo en
evolutivo reflejando
la hora

IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE SÉPTICO (En consulta de urgencias)

- Paciente con aviso desde triaje y nivel de gravedad 1-2.
- El paciente que presente cualquier síntomas de infección grave: Fiebre o hipotermia, Tiritonas/escalofríos, Semiología focal infecciosa, lesiones cutáneas (rash, petequias, livideces, cianosis...), En pacientes con mayor riesgo de infecciones graves: cualquier síntoma agudo o afectación considerable del estado general sin una clara atribución etiológica alternativa ó Alteraciones en pruebas de laboratorio (si están disponibles).

Paciente con SOSPECHA de INFECCIÓN

CONSULTA POLIVALENTES
En pacientes con nivel de alerta 2
Valorar **Vulnerabilidad/Fragilidad**

- **Inmunodepresión** (> 65 años, Inmunodepresión, Inmunosupresión)
- **Comorbilidades** (> 1 ó 1 grave/descompensada; Charlson > 2)
- **Material Protésico** (Sondas, Catéteres, Prótesis)
- **Riesgo de colonización por B multiR*** (Ver debajo)

No

Seguimiento y Reevaluar Gravedad según Evolución

Sí

REEVALUAR GRAVEDAD

BOX DE CRÍTICOS
Paciente con nivel de alerta 1

➤ **ALERTA INFECCIÓN GRAVE ACTIVADA:** Acciones en anexo siguiente.

➤ **Monitorizar (cada 1-2 h):** Constantes (FR, FC, TA, Temp.), Nivel de Conciencia (Glasgow) y Pulsioximetría
➤ Hemograma, PCR, PCT, Creatinina, GSV con Lactato, PaO₂, Bilirrubina, Orina.

- Monitorizar (cada 1-2 h): Constantes (FR, FC, TA, Temp.), Nivel de Conciencia (Glasgow) y Pulsioximetría
- Hemograma, PCR, PCT, Creatinina, GSV con Lactato, PaO₂, Bilirrubina, Orina.
- Hemocultivo, Otros Cultivos
- Opcional: Sondaje para monitorizar Diuresis

OBSERVACIÓN
CAMAS-SILLONES

ITEM A EVALUAR	3 PUNTOS	2 PUNTOS	1 PUNTO
FRECUENCIA RESPIRATORIA:	[3] > 24/min	[2] > 20/min	[1] > 16/min
PULSIOXIMETRÍA:	[3] < 92%	[2] < 94%	[1] < 96%
PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA:	[3] < 91 mmHg	[2] < 100 mmHg	
FRECUENCIA CARDÍACA:	[3] > 130/min	[2] > 110/min	[1] > 100
NIVEL DE CONCIENCIA:	[3] Confusión, Glasgow < 15		
TEMPERATURA:	[3] < 35.1°C	[2] > 38.6°C	[1] > 38°C ó < 36°C
DIURESIS:	[3] < 10 mL/h	[2] < 30 mL/h	[1] < 45 mL/h
LEUCOCITOSIS:			[1] > 12.000/mmc ó < 4.000/mmc
PROTEINA C REACTIVA:		[2] > 200 mg/L	[1] > 100 mg/L
PROCALCITONINA:	[3] > 10 ng/mL	[2] > 2 ng/mL	[1] > 0.5 ng/mL
LACTATO:	[3] > 4 mmol/L	[2] > 3 mmol/L	[1] > 2 mmol/L
CREATININA:	[3] > 3.4 mg/dL	[2] > 1.9 mg/dL	[1] > 1.2 mg/dL
PLAQUETAS:	[3] < 50.000/mmc	[2] < 100.000 mmc	[1] < 150.000/mmc
BILIRRUBINA	[3] > 5.9 mg/dL	[2] > 1.9 mg/dL	[1] > 1.2 mg/dL

¿ 1-2 Puntos?

No

Seguimiento y Reevaluar Gravedad según Evolución

Sí

Reevaluar Gravedad con frecuencia (1-4 h)

≥ 3 Puntos

ALARMA INFECCIÓN GRAVE

SEPSIS/SOFA

ALERTA INFECCIÓN GRAVE

ALARMA para LABORATORIO URGENCIAS MICROBIOLÓGICAS

- Contactar con microbiólogo de guardia (**750807**).
- Extraer y enviar rápidamente a microbiología hemocultivos (mínimo 2 tomas con frasco aerobio y anaerobio cada una).
- Extracción y envío de otras muestras según sospecha foco infeccioso (orina, LCR, muestras respiratorias, catéter, drenajes,...)
- Si T2, petición de tubo de 4ml con EDTA suministrado por laboratorio de microbiología.

Test rápidos ofertados:

- Sobre sangre periférica (hemocultivo negativo o no hemocultivo): **T2 Biosystems**.
- Sobre hemocultivo positivo: **Maldi-tof MS, Accelerate** (o similar), **FilmArray**.

TRATAMIENTO ANTIBIÓTICO EN < 1 HORA

(Que sea activo frente a > 95% de las posibles etiologías)

- Considerar:
 - Posible Foco/Síndrome
 - Nivel de Gravedad
 - Riesgo de **Colonización por Bacterias Resistentes**

CONSULTA EXPERTOS: 699182-699183-613080-120223
Ayúdate de la [GUÍA DE TRATAMIENTO LOCAL](#) y los protocolos de tratamiento incluidos en [ATHOS-PRISMA](#)

RIESGO DE COLONIZACIÓN POR BACTERIAS MULTI-R si:

- Antibioterapia previa (3-6 m)
- Contactos previos recientes con Sistema Sanitario o Residencias Sociosanitarias (3-6 m)
- Inmunodepresión
- Colonización previa o contacto con paciente con colonización conocida

SOPORTE HEMODINÁMICO, RCP

- Fluidoterapia (fase 1 o de reanimación durante los primeros 30-60 min):
 - 30 ml/kg de peso de solución balanceada (tipo Ionolyte o similar) o cristaloides (SSF 0.9%)
- Estrategia guiada por Lactato★: (GSV con lactato)
- **AVISAR UCI (754318) si en cualquier momento presenta:**
 - Lactato > 4 meq/L
 - Inicio Noradrenalina (perfusión de 10 mg en 100 ml de SG5%, inicio <5ml/h)
 - Oliguria > 2 horas (<0.3 ml/kg/h)

Búsqueda de **FOCO** (< 6 h en paciente Grave)

- | | |
|------------------|--------------------------|
| • Examen Físico | • Tira reactiva de Orina |
| • Rx de Tórax | • Ecografía abdominal |
| • Punción Lumbar | • Cirugía |
| • Otras | |

★ Estrategia guiada por lactato desarrollada en anexo siguiente

SOPORTE HEMODINÁMICO, RCP ESTRATEGIA GUIADA POR LACTATO

